

Documentation-Driven Threat Analysis

DermaTriage Case Study

Documentation + Base Analysis

Ricostruzione DDTA del progetto DermaTriage

La documentazione di progetto occupa la parte principale della pagina. La Base Analysis viene riportata in parallelo nella colonna laterale soltanto quando esiste un significato documentale da analizzare.

Struttura del case study

Il documento segue la progressione DDTA dal contesto generale del progetto agli elementi documentali successivi. Ogni elemento viene presentato nella colonna documentale; la colonna Base Analysis mostra esclusivamente l'analisi derivabile da quel significato, senza introdurre fatti di progetto aggiuntivi.

1 Contesto generale del progetto

Documentazione DDTA

Project Problem Framing

Il problema che DermaTriage deve affrontare e' il supporto al triage precoce di casi dermatologici relativi a lesioni potenzialmente oncologiche. Il progetto parte dalle informazioni gia' disponibili sul caso per determinarne l'urgenza e una priorita' operativa di presa in carico, con l'obiettivo di favorire un instradamento specialistico tempestivo.

Base Analysis

Base Analysis

Il contesto generale definisce il problema affrontato dal progetto, ma non introduce ancora un elemento documentale strutturato da decomporre in referenti e proposizioni. La Base Analysis viene quindi applicata a partire dagli elementi DDTA successivi, quando il significato governato rende identificabili responsabilita', relazioni, condizioni o risultati analizzabili.

2 MR-01 - Valutazione di triage del caso dermatologico

Documentazione DDTA

MacroRequirement

Intent

Determinare, a partire dalle informazioni disponibili sul caso dermatologico, l'urgenza del caso e la relativa priorit  operativa di triage.

Context

La valutazione di triage parte dalle informazioni disponibili sul caso. Quando non   presente un'immagine della lesione, il progetto prevede un percorso basato sui sintomi disponibili.

Stakeholders

Paziente.

Scope

IN: determinazione dell'urgenza del caso e della relativa priorit  operativa di triage, anche quando l'immagine non   presente.

OUT: indicazione della destinazione specialistica; validazione o correzione medica dell'esito; adattamento successivo del comportamento del sistema sulla base della revisione clinica.

Assumptions / Constraints

–

dependsOn

None

Base Analysis

Base Analysis

La Base Analysis di questo MacroRequirement non   ancora stata eseguita. Questa colonna resta intenzionalmente non popolata nel presente passaggio e verr  compilata nel successivo step di analisi, senza modificare il significato documentale dell'MR.

3 MR-02 - Indicazione della destinazione specialistica

Documentazione DDTA

MacroRequirement

Intent

Determinare un'indicazione di destinazione specialistica per il caso dermatologico, a supporto del successivo instradamento verso l'assistenza appropriata.

Context

DermaTriage associa al risultato del processo di triage un'informazione orientata alla destinazione specialistica. La documentazione disponibile non stabilisce il vocabolario delle destinazioni, la regola di selezione né la responsabilità di assegnazione o prenotazione.

Stakeholders

–

Scope

IN: produzione di un'indicazione di destinazione specialistica per il caso.

OUT: prenotazione; assegnazione effettiva; tassonomia completa delle destinazioni; regola completa di selezione e fallback.

Assumptions / Constraints

–

dependsOn

None

STOP AT MR

Il significato macro è sufficientemente distinguibile, ma la documentazione disponibile non governa commitment ulteriori sufficienti per una decomposizione fedele. Il branch si arresta intenzionalmente a MacroRequirement.

Base Analysis

Base Analysis

La Base Analysis di questo MacroRequirement non è ancora stata eseguita. Il successivo passaggio analitico dovrà consumare soltanto il significato qui documentato, preservando lo STOP AT MR e senza inferire regole di selezione specialistica mancanti.

4 MR-03 - Validazione e correzione medica degli esiti

Documentazione DDTA

MacroRequirement

Intent

Consentire al medico di validare o correggere gli esiti prodotti da DermaTriage e rendere disponibile il risultato della revisione nel contesto del caso cui si riferisce.

Context

Gli esiti prodotti da DermaTriage possono essere sottoposti a revisione medica. Il medico può validarli o correggerli; il progetto gestisce il risultato della revisione senza includere in questa responsabilit  il successivo adattamento del sistema.

Stakeholders

Medico.

Scope

IN: gestione del risultato della validazione o correzione medica e sua associazione al caso o all'esito cui si riferisce.

OUT: meccanismi tecnici di scambio e autenticazione; adattamento successivo del comportamento del sistema sulla base delle correzioni raccolte.

Assumptions / Constraints

–

dependsOn

None

Base Analysis

Base Analysis

La Base Analysis di questo MacroRequirement non   ancora stata eseguita. Nel passaggio successivo dovr  essere verificato quali referenti e relazioni siano realmente derivabili dal significato documentato, senza introdurre una semantica della revisione clinica non stabilita dalla documentazione.

5 MR-04 - Adattamento controllato sulla base della revisione clinica

Documentazione DDTA

MacroRequirement

Intent

Consentire l'adattamento controllato del comportamento di DermaTriage utilizzando i risultati delle validazioni e correzioni mediche raccolte.

Context

Le correzioni mediche vengono utilizzate per modificare nel tempo il comportamento del sistema. L'evoluzione dei prompt e il riaddestramento del classificatore sono modalita' correnti di realizzazione di questa responsabilita' e non ne definiscono l'identita' macro.

Stakeholders

Medico.

Scope

IN: adattamento del comportamento del sistema sulla base dei risultati della revisione medica disponibili.

OUT: produzione del giudizio di validazione o correzione medica; dettagli dei singoli meccanismi di adattamento.

Assumptions / Constraints

–

dependsOn

MR-03

Base Analysis

Base Analysis

La Base Analysis di questo MacroRequirement non e' ancora stata eseguita. Il successivo passaggio dovra' preservare la dipendenza semantica da MR-03 senza trasformarla in containment o co-ownership e senza promuovere automaticamente i meccanismi correnti di adattamento a responsabilita' macro autonome.

6 Indice di integrità' delle pagine

Regola di verifica

Ogni pagina possiede un MD5 del proprio contenuto canonico. Il calcolo esclude il valore MD5 stampato sulla pagina, gli header/footer e i metadati di impaginazione esterni al relativo blocco di contenuto. Per la pagina dell'indice, gli hash delle pagine precedenti fanno parte del contenuto controllato; il solo hash della pagina indice viene sostituito dal token canonico <SELF> durante il calcolo, evitando una dipendenza circolare.

Pag.	Contenuto	MD5 contenuto
1	Frontespizio e struttura del case study	ccabe4bed7cca4d2f68a2005e42f36e3
2	Contesto generale del progetto - Project Problem Framing	0fb76dc0491da2793823b20571e5268b
3	MR-01 - Valutazione di triage del caso dermatologico	6d31dd026458ea1ce9ff658056f4005d
4	MR-02 - Indicazione della destinazione specialistica	875bd4afdf8e6be8b1995cc234253f2e
5	MR-03 - Validazione e correzione medica degli esiti	cb96dc22bf50d9f157f55b0374c9ca91
6	MR-04 - Adattamento controllato sulla base della revisione clinica	eec204cc9e490ffbdb154dd3ad79505c
7	Indice di integrità' delle pagine	26ab3bc6525c4c4c7ac958045a2487d9

Quando una pagina viene modificata intenzionalmente, cambia il suo MD5. Le pagine non interessate dal passaggio devono mantenere lo stesso valore; una variazione inattesa segnala una modifica da riesaminare prima di proseguire.